

TEMA 3.2 • OBSTETRICIA

Determinación de la Edad Gestacional (EG)

PERFIL EUNACOM 2.01.2.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Determinación de la Edad Gestacional (EG)

Conceptos Clave

- **EG** = tiempo desde la **FUR** (fecha de última regla) hasta hoy
- La EG inicia **2 semanas antes de la concepción** (la concepción es al día 14 del ciclo)
- Al embarazarse, ya hay 2 semanas de EG

Métodos de Determinación

1. Ecografía (mejor método — especialmente precoz)

Error de la ecografía según EG al momento del examen:

TABLA 3.2.1: EG EN ECOGRAFÍA VS MARGEN DE ERROR	
EG EN ECOGRAFÍA	MARGEN DE ERROR
< 9 semanas	± 4–5 días
9–16 semanas	± 7–10 días (~ 1 semana)
16–22 semanas	± 10–14 días (~2 semanas)
22–28 semanas	± 14–21 días (2–3 semanas)
> 28 semanas	± 21–28 días (3–4 semanas)

2. FUR (Fecha de Última Regla)

Útil solo si es **segura Y confiable**: - **Segura**: La paciente recuerda la fecha exacta - **Confiable**: Ciclos regulares, sin ACO, sin lactancia materna

Regla: Ecografía vs. FUR

Si **FUR es acorde** (cae dentro del margen de error de la eco) → **gana la FUR**

Si **FUR es discorda** (fuera del margen de error) → **gana la ECO**

Si **hay múltiples ecografías** → siempre gana la **primera** (menor margen de error)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Prácticamente siempre que la eco es precoz (< 16 semanas) gana la eco. Cuando la eco es tardía (> 28 sem), gana la FUR si es segura y confiable.

Si el bebé se ve más pequeño que la EG dada por la primera eco → sospechar **RCIU**, no cambiar la EG.

Fórmulas Útiles

Fecha Probable de Parto (Fórmula de Naegele)

FUR + 7 días – 3 meses = fecha estimada de parto. (Mejor usar software: FUR + 280 días = fecha probable de parto)

Longitud Céfaló-Nalgas (LCN) — 1er trimestre hasta 12 semanas

EG (semanas) = LCN (cm) + 6.5

TABLA 3.2.2: LCN VS EG APROXIMADA

LCN	EG APROXIMADA
1 cm	7.5 semanas
2 cm	8.5 semanas
5 mm (0.5 cm)	7 semanas

Saco Gestacional (SG)

EG (días) = diámetro del SG (mm) + 30 → dividir por 7 para semanas. - SG visible desde ~5 semanas - SG ≥ 25 mm sin embrión = **huevo anembrionado** = **aborto retenido**

Altura Uterina (AU) — imprecisa, solo referencial

EG (semanas) ≈ AU (cm) + 4

Parámetros Ecográficos por Trimestre

TABLA 3.2.3: TRIMESTRE VS PARÁMETROS	
TRIMESTRE	PARÁMETROS
1er trimestre	Longitud céfalo-nalgas (LCN) — la más importante
2do trimestre	Diámetro biparietal (DBP — el más influyente), perímetro cefálico, perímetro abdominal, longitud femoral
3er trimestre	Mismos que 2do trimestre; longitud femoral gana importancia relativa

Movimientos Fetales

- Primigestas: desde las 18–20 semanas
- Multíparas: desde las 16–18 semanas
- (Son mala referencia para determinar EG)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Determinación de la Edad Gestacional (EG): La EG inicia 2 semanas antes de la concepción (la concepción es al día 14 del ci... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Determinación de la Edad Gestacional (EG). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Conceptos Clave
- Métodos de Determinación
- 1. Ecografía (mejor método — especialmente precoz)
- 2. FUR (Fecha de Última Regla)
- Regla: Ecografía vs. FUR
- Fórmulas Útiles
- Fecha Probable de Parto (Fórmula de Naegele)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL (EG))**PREGUNTA 1**

En relación a Determinación de la Edad Gestacional (EG): La EG inicia 2 semanas antes de la concepción (la concepción es al día 14 del ci... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Determinación de la Edad Gestacional (EG) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Determinación de la Edad Gestacional (EG) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Determinación de la Edad Gestacional (EG) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Determinación de la Edad Gestacional (EG) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Determinación de la Edad Gestacional (EG) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Determinación de la Edad Gestacional (EG)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Determinación de la Edad Gestacional (EG). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL (EG)

:::tip Prácticamente siempre que la eco es precoz (< 16 semanas) gana la eco. Cuando la eco es tardía (> 28 sem), gana la FUR si es segura y confiable. Si el bebé se ve más pequeño que la EG dada por la primera eco → sospechar RCIU, no cambiar la EG. ::: FUR + 7 días – 3 meses = fecha estimada de parto. (Mejor usar software: FUR + 280 días = fecha probable de parto)